

Chaos vs struktura

Chaotyczne jedzenie to „wszystko-albo-nic” — ekstremalna restrykcja lub niekontrolowane spożycie. Herman & Polivy 1983: paradoksalnie restrykcja napędza epizody. Struktura jako antidotum.

CZAS: 20 min · stabilizacja struktury · Etap 2-3 CBT-E (sesje 6-12) · po 3+2

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Herman & Polivy (1983, *restraint theory*)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **mechanizm chaosu jedzenia** i efekt „*what-the-hell*” (sekcja 1), zobacz **sześć elementów strukturyzacji** (sekcja 2). Sekcja 3 — Twoja mapa chaosu. Sekcja 4 — plan na najbliższe 4-8 tygodni.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Chaotyczne jedzenie to „wszystko-albo-nic” — albo ekstremalna restrykcja, albo niekontrolowane spożycie. Herman & Polivy (1983, *restraint theory*): paradoksalnie im bardziej pacjent próbuje **restrykcji**, tym silniejsze są **epizody**. Sztynne reguły + dychotomia „*dobry vs zły jedzeniowo*” prowadzą do **efektu „what-the-hell”** (Polivy, Herman & Deo, 2010): „już zjadłem/-am jedno ciastko, już zepsułem/-am dzień, więc zjem wszystko”. Fairburn (2008): walka z chaosem to **budowanie struktury** (rytm 3+2) + **różnorodności** (brak „zakazanych” jedzeń) + **elastyczności**. Cel: „normalne, elastyczne jedzenie” — nie idealne, nie kontrolowane, ale też nie chaotyczne. **4-8 tygodni** systematycznej pracy po wprowadzeniu regularnego jedzenia.

01 ● Efekt „*what-the-hell*” — pułapka restrykcji

Mechanizm: sztywna reguła („nie wolno słodczy”) → złamanie reguły → myślenie wszystko-albo-nic („dzień zepsuty”) → „skoro zepsute, to zjem wszystko” → **epizod** → kompensacja → silniejsza restrykcja od jutra → cykl.

02 ≡ Sześć elementów strukturyzacji

1 · REGULARNOŚĆ 3+2

Pięć okazji jedzenia, maks. 4h przerwy. Fundament strukturyzacji — bez tego nic innego nie działa.

2 · STAŁE PORY

Mniej więcej te same godziny każdego dnia. Ciało uczy się *kiedy* dostanie jedzenie i przestaje „panikować” między posiłkami.

3 · NIE POMIJAJ

Każdy pominięty posiłek to *aktywna restrykcja* → ryzyko epizodu. Nawet jeśli „nie masz głodu” — jedz coś małego.

4 · NIE KOMPENSUJ

Po „złamaniu reguły” — nie głodówka, nie wymioty, nie ćwiczenia kompensacyjne. Wróć do następnej okazji w planie. Bez kary.

5 · MONITOROWANIE DZIENNIKA

Codzienne zapisywanie pozwala *zobaczyć* wzorec, który inaczej jest niewidoczny.

6 · CIERPLIWOŚĆ 4-8 TYGODNI

Chaos → struktura to *proces*, nie jednorazowa zmiana. Pierwsze dni są najtrudniejsze. Po 4-8 tygodniach struktura staje się *nowym domyślnym wzorcem*.

Rozpoznaj swój wzorzec chaosu — kiedy występuje, jakie ma formy, co go aktywuje. To pierwszy krok do strukturyzacji — bez świadomości chaosu nie da się go zaadresować.

MOJE TYPOWE WZORCE CHAOSU

— pomijanie posiłków, nocne jedzenie, oscylacja między restrykcją a epizodem

MOJE SZTYWNE REGUŁY, KTÓRE AKTYWUJĄ EFEKT „WHAT-THE-HELL”

— „nie wolno X”, „tylko do Y”, „nie po Z”; spisz konkretnie

CO WPROWADZAM JAKO PIERWSZE

— mały krok; np. „śniadanie codziennie o 8:00”, „bez pomijania obiadu”

CO ZAUWAŻĘ PO 2 TYGODNIACH

— jak będę wiedział/-a, że struktura zaczyna działać; mierzalne sygnały

Klucz: walka z chaotycznym jedzeniem to *nie* walka z „brakiem dyscypliny” — to walka z **regułami**, które same w sobie wywołują chaos. Herman & Polivy (1983): osoby z wysoką restrykcją żywieniową zjadają **3x więcej** w sytuacji „złamania reguły” niż osoby bez restrykcji. To nie kwestia *silnej woli* — to fizjologia + psychologia razem. Polivy, Herman & Deo (2010): efekt „what-the-hell” jest **uniwersalny** — występuje także u osób bez bulimii, gdy są poddane sztywnym regułom dietetycznym. Wniosek: bulimia *nie* jest „brakiem dyscypliny”, to *nadmiar dyscypliny*, która się załamuje. Paradoks: **im mniej** reguł, tym mniej epizodów. **Im więcej** elastyczności, tym więcej spokoju. To wymaga przeciwnego myślenia niż w dietetyce konsumenckiej, która oferuje „regulację przez kontrolę”. CBT-E mówi: *regulacja przez regularność, nie kontrolę*. Struktura zewnętrzna (3+2) zastępuje wewnętrzną sztywność, a chaos znika nie przez większą kontrolę, lecz przez *mniej* potrzeby kontroli. Po 4–8 tygodniach większość pacjentów odczuwa **wyraźny spokój wokół jedzenia** — bo nie ma już o co walczyć.